

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Revisão Flash • SESSÃO 09

Afecções Urológicas

O essencial para a prova em uma página



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Afecções urológicas

Leitura de 5 minutos

EM UMA FRASE

AINE na cólica e descompressão se houver febre; sonda na retenção; escroto agudo é torção até prova em contrário; e nunca sondar com sangue no meato.

- 1 **Cólica renal:** AINE é a 1ª escolha. Opióide é 2ª opção.
- 2 **Imagem:** TC sem contraste confirma. Gestante e criança começam pela ultrassonografia.
- 3 **Cálculo < 5 mm no ureter distal:** 89% eliminam sozinhos.
- 4 **α -bloqueador:** para cálculo do ureter distal > 5 mm.
- 5 **Obstrução + febre:** duplo J ou nefrostomia + antibiótico; o cálculo fica para depois.
- 6 **Retenção:** sondagem de alívio; se a sonda não passa, cistostomia.
- 7 **Torção:** janela de 4–6 h; o Doppler não pode atrasar a cirurgia.
- 8 **Sangue no meato:** não sondar; uretrografia antes.

TORÇÃO × EPIDIDIMITE

	TORÇÃO	EPIDIDIMITE
<i>Cremastérico</i>	Ausente	Presente
<i>Prehn</i>	Não alivia	Alivia
<i>Doppler</i>	Sem fluxo	Hiperfluxo

PEGADINHA

Fluxo ao Doppler **não exclui** torção. Na sondagem, só insufla o balão depois de ver urina.

CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Sei a analgesia e a imagem da cólica renal
- ☐ Sei quando descomprimir o rim
- ☐ Sei conduzir a retenção urinária
- ☐ Sei os remédios da HPB e quando operar
- ☐ Diferencio as três causas de escroto agudo
- ☐ Separo priapismo isquêmico do não isquêmico
- ☐ Sei a técnica e as contraindicações da sondagem